CUESTIONARIO 1 GASTROENTEROLOGIA	2024
1. Un paciente cirrótico, con ascitis, presenta un cuadro de dolor abdominal y fiebre, por lo que se realiza una paracentesis diagnóstica, que da salida a un líquido citrino, con 1.300 polimorfonucleares por mm3. Se indica tratamiento con cefotaximo por 7 días, con excelente respuesta. ¿Qué indicación se debe dar ahora que el cuadro agudo se resolvió?	a.Antibióticos profilácticos b.Albúmina profiláctica c.Paracentesis periódicas d.Corticoides orales e.Instalación de TIPS
2. Un paciente de 3 años presenta un cuadro de esteatorrea y baja de peso, asociada a signos carenciales (caída de cabello, queilitis angular, piel seca). Se realiza un test de Sudán III, que resulta positivo y un test de la D-xilosa, que resulta normal. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable?	a.Déficit de páncreas exocrino b.Enfermedad celíaca c.Giardiasis intestinal d.Síndrome de intestino corto e.Diarrea crónica inespecífica
3. ¿Cuál es el diagnóstico más probable ante un paciente de 30 años con dolor abdominal e importante constipación, de dos años de evolución?	a.Colitis ulcerosa b.Enfermedad celiaca c.Síndrome de intestino irritable d.Pólipos intestinales e.Cáncer de colon
4. Un paciente consume 20 comprimidos de paracetamol hace 6 horas. Está asintomático. ¿Cuál es la conducta?	a.Observar evolución b.Realizar lavado gástrico c.Solicitar pruebas hepáticas d.Solicitar niveles plasmáticos de paracetamol e.Administrar bicarbonato de sodio por vía endovenosa
5. Un paciente de 57 años consulta por dolor abdominal postprandial frecuente, asociado astenia. Refiere que presenta dolor epigástrico intenso, luego de comer y luego de consumir alcohol. Al preguntarle, refiere que ha bajado de peso y que toma una botella de vino al día y que los fines de semana el consumo puede ser de hasta 5 botellas en un día, pero que últimamente ha consumido menos, porque el dolor lo limita. La conducta más adecuada es:	a.Solicitar endoscopía digestiva alta b.Indicar régimen cero e iniciar analgésicos e hidratación endovenosa c.Solicitar angiografía mesentérica d.Resolver quirúrgicamente e.Solicitar glicemia de ayuno y TAC de abdomen
6. Un paciente de 25 años consulta por diarrea, que inició hace 3 meses, que en ocasiones es sanguinolenta. Además, presenta pujo y tenesmo frecuente y ha bajado 6 kilogramos de peso. Al examen físico, presenta dolor abdominal a la palpación, ruidos hidroaéreos aumentados y úlceras orales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?	a.Colitis ulcerosa b.Enfermedad de Cröhn c.Enfermedad celiaca d.Colitis pseudomembranosa por C. difficile e.Parasitosis intestinal
7. Una paciente de 50 años, con antecedente de hipotiroidismo, en tratamiento con 100 ug de levotiroxina al día, consulta por astenia e ictericia leve. Se solicitan exámenes generales, entre los que destacan TSH: 0,7 mg/dl, bilirrubina: 2,5 mg/dl, FA: 140 UI/L, GGT: 80 UI/L, GOT: 430 UI/L, GPT: 397 UI/L, protrombinemia: 60%. Refiere que consume máximo una copa de vino o un vaso de cerveza al día y niega conductas sexuales de riesgo. Se solicita glicemia de ayuno, que resulta 70 mg/dl y la serología descarta hepatitis de causa viral. ¿Cómo debe proseguir el estudio de esta paciente?	a.Solicitar endoscopía digestiva alta b.Solicitar anticuerpos antimitocondriales c.Solicitar hemograma-VHS d.Solicitar colangioresonancia e.Solicitar anticuerpos antinucleares y anti-músculo liso
8. Una paciente de 67 años presenta constipación de 4 meses de evolución, que en ocasiones se acompaña de heces sanguinolentas. Se realiza una colonoscopía que muestra una tumoración de 6 cm de largo, en el colon sigmoides, de superficie irregular, que se biopsia, resultando un adenocarcinoma tubular. ¿Cuál es la conducta más adecuada?	a.Solicitar ecografía abdominal b.Solicitar TAC de tórax, abdomen y pelvis c.Solicitar resonancia magnética nuclear de abdomen y pelvis d.Solicitar endoscopía digestiva alta e.Realizar nueva colonoscopía, para la resección del tumor por vía colonoscópica
9. Un paciente es diagnosticado de úlcera duodenal, con test de ureasa positiva. Se indican 14 días de antibióticos (amoxicilina y claritromicina) y 6 semanas de omeprazol. El paciente evoluciona positivamente desde el punto de vista clínico y sus síntomas desaparecen. ¿Cuál es la conducta más adecuada?	a.Controlar con nueva endoscopía digestiva alta y test de ureasa b.Solicitar antígeno en deposiciones para H. pylori c.Mantener el omeprazol, a permanencia d.Repetir el tratamiento antibiótico en 6 meses e.Observar evolución e indicar reconsulta en caso de recurrencia de los síntomas
10. Un paciente, con IRC, está en espera de ingresar a hemodiálisis, por lo que se piden algunos exámenes que muestran antígeno VHBs negativo, IgG anti-VHBs positivo, IgG anti-VHC positivo. ¿Cuál es la opción más probable?	a.Se descartan las hepatitis virales B y C b.Tiene hepatitis B sola c.Tiene hepatitis C sola d.Tiene hepatitis B y C e.Tiene crioglobulinemia

Lia...

CUESTIONARIO 2 GASTROENTEROLOGIA	2024
1. Un paciente de 68 años presenta un cuadro de dificultad para tragar, que afecta principalmente a la ingesta de líquidos. El diagnóstico de sospecha es:	a.Acalasia esofágica b.Divertículo de Zenker c.Cáncer de esófago d.Esófago de Barret e.Reflujo gastroesofágico
2. Un paciente de 56 años, portador de una cirrosis por consumo crónico de alcohol, consulta por gran aumento del perímetro abdominal. Actualmente ya no consume alcohol y presenta ascitis a tensión en el examen físico. Se realiza paracentesis diagnóstica, que muestra salida de líquido ascítico transparente con 10 células por mm3 y albúmina de 2,2 g/dl. La conducta más adecuada es:	a.Realizar paracentesis evacuadora, con reposición de albúmina b.Iniciar antibióticos por vía endovenosa c.Iniciar antibióticos orales, de manera profiláctica d.Iniciar espironolactona oral e.Observar evolución
3. Un paciente de 61 años, cirrótico, se realiza una endoscopía digestiva alta, que muestra várices esofágicas de tamaño moderado. La conducta más adecuada es:	a.Administrar beta-agonistas adrenérgicos b.Administrar beta-bloqueadores adrenérgicos c.Iniciar omeprazol d.Instalar un TIPS de manera urgente e.Realizar ligadura endoscópica de las várices
4. El tratamiento de elección de la giardiasis intestinal en adultos es:	a.Cotrimoxazol b.Mebendazol c.Albendazol d.Tinidazol e.Praziquantel
5. Una paciente de 28 años presenta un cuadro de diarrea acuosa, de 30 días de evolución, asociado a pujo y dolor abdominal tipo cólico. Refiere que ha presentado sensación febril y en el último tiempo, las deposiciones se han vuelto disentéricas. El diagnóstico más probable es:	a.Colitis parasitaria b.Colitis viral c.Colitis bacteriana d.Colitis ulcerosa e.Colitis pseudomembranosa
6. Un paciente de 30 años presenta ardor epigástrico, frecuente, por lo que se solicita una endoscopía digestiva alta, que resulta normal. Se inicia esomeprazol oral 40 mg/12 horas, por sospecha de reflujo gastroesofágico; sin embargo, los síntomas persisten. ¿Qué examen es más adecuado para descartar la presencia de reflujo?	a.Prueba terapéutica con lansoprazol b.Solicitar manometría esofágica c.Una nueva endoscopía digestiva alta d.Una pH-metría esofágica de 24 horas e.Las radiografías baritadas
7. Un paciente de 55 años, diabético tipo 2, presenta un cuadro de malestar abdominal de 2 semanas de evolución. Al examen físico destaca hígado palpable 4 cm bajo el reborde costal, doloroso. Se solicitan exámenes que muestran: lipasa: 100 UI/L, GGT: 45 UI/L, GOT: 250 UI/L, GPT: 206 UI/L, bilirrubina: 1,8 mg/dl, fosfatasas alcalinas: 108 UI/L. Al preguntarle dirigidamente, refiere consumir una copa de vino, algunos fines de semana. El diagnóstico más probable es:	a.Esteatohepatitis no alcohólica b.Pancreatitis crónica c.Cáncer de páncreas d.Hepatitis alcohólica e.Hepatitis viral
8. Un paciente de 20 años presenta un cuadro de diarrea y flatulencia, de algunos meses de evolución. Además, presenta dolor abdominal tipo cólico y gotas de grasa en las deposiciones. Se solicita una endoscopía digestiva alta y se toma una biopsia duodenal, que muestra atrofia de las vellosidades intestinales y alargamiento de las criptas. Respecto a este paciente, es correcto afirmar que:	a.Probablemente tiene un tumor productor de gastrina b.Se debe indicar erradicación de H. pylori c.Su diagnóstico más probable es un trastorno digestivo funcional d.La enfermedad celíaca es el diagnóstico más probable e.La enfermedad de Cröhn es el diagnóstico más probable
9. Un paciente presenta un cuadro de malestar general, gran decaimiento y posteriormente, aparición de ictericia de escleras, mucosas y piel, asociada a coluria y acolia. Se solicitan exámenes, que muestran positividad de los anticuerpos IgM anti-VHA. ¿Cuál de las siguientes alternativas obliga a hospitalizar al paciente?	a.Edad mayor a 20 años b.Embarazo c.Asterixis d.Niveles plasmáticos de GOT mayores a 5.000 e.Niveles plasmáticos de bilirrubina mayores a 10 mg/dl
10. Una paciente de 60 años, se realiza exámenes como cheque médico, entre los que figuran pruebas hepáticas con los siguientes resultados: Albúmina: 4,0 g/dl, protrombinemia: 100%, GGT: 32 UI/L, GOT: 32 UI/L, GPT: 10 UI/L, FA: 62 UI/L, Bilirrubina total: 2,8 mg/dl, bilirrubina directa: 0,2 mg/dl. El diagnóstico más probable es:	a.Cáncer b.Colédocolitiasis c.Hepatitis d.Síndrome de Gilbert e.Hemólisis
11. Niño de 5 años, que ingiere 13 gramos de paracetamol por error. La conducta más adecuada es:	a.Administrar carbón activado y monitorización cardíaca b.Realizar lavado gástrico y administrar

Lia...

	bicarbonato endovenoso c.Realizar diálisis de urgencia d.Indicar N-acetilcisteína, según niveles plasmáticos de paracetamol e.Tranquilizar a la madre y explicarle los signos de alarma para reconsultar
12. Un paciente de 44 años presenta dolor abdominal epigástrico intenso, constante, de 24 horas de evolución, asociado a vómitos alimentarios en varias oportunidades. Se aprecia muy adolorido, sudoroso, taquicárdico, con tendencia a la hipotensión. Se observa un área de equimosis periumbilical. El abdomen es blando, doloroso a la palpación, con signos de irritación peritoneal y disminución marcada de los ruidos hidroaéreos. El diagnóstico más probable es:	a.Embolia mesentérica b.Trombosis de vena mesentérica c.Estallido hepático d.Perforación de úlcera péptica e.Pancreatitis aguda
13. En una radiografía de abdomen en supino se ve el ligamento falciforme. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:	a.Ascitis. b.Perforación intestinal. c.Peritonitis. d.Oclusión intestinal. e.Ileo paralítico.
14. Un paciente de 57 años, alcohólico, de larga data, presenta dolor abdominal recurrente, localizado en el epigastrio y que aparece especialmente después de comer. Refiere además deposiciones esteatorreicas y baja de peso. El diagnóstico más probable es:	a.Hepatitis alcohólica b.Colelitiasis c.Enfermedad celíaca d.Pancreatitis crónica e.Angina mesentérica
15. Un niño de 3 años presenta un cuadro diarreico de un día de evolución, asociado a irritabilidad y fiebre de hasta 38,2°C. Al examen presenta FC y PA normales para la edad, constatándose mucosas secas y llanto sin lágrimas. La conducta más adecuada es:	a.Administrar bolo de suero fisiológico 20 cc/kg y reevaluar b.Indicar sales de rehidratación oral 50cc/Kg, a tomar en 4 horas y reevaluar c.Indicar sales de rehidratación oral 100cc después de cada deposición diarreica d.Indicar sales de rehidratación oral y antibióticos orales e.Indicar sales de rehidratación oral y antiespasmódicos orales
16. El tratamiento antibiótico de elección para un paciente cursando un cuadro disentérico agudo, de manejo ambulatorio es:	a.Clindamicina b.Ciprofloxacino c.Amoxicilina + ácido clavulánico d.Metronidazol e.Albendazol
17. Un paciente de 31 años consulta por diarrea de varios meses de evolución, con deposiciones brillantes, asociadas a lientería y distensión abdominal frecuente. El examen físico es normal. La etiología más probable es:	a.Malabsorción intestinal b.Infección parasitaria c.Infección viral d.Enfermedad inflamatoria intestinal e.Funcional
18. Un paciente de 24 años consulta por dolor epigástrico recurrente, de características urentes. Usted solicita una endoscopía digestiva alta que demuestra una úlcera gástrica activa, sin estigmas de sangrado reciente. El test de ureasa resulta positivo. La medida terapéutica de primera línea es:	a.Omeprazol en dos dosis diarias, a permanencia. b.Antibióticos biasociados, durante 7 a 14 días, junto a omeprazol por 4 semanas. c.Dieta estricta, evitando grasas, condimentos e irritantes y control endoscópico cada 3 meses. d.Inhibidores H2 diarios, asociados a antiácidos, según síntomas. e.Prohibir el uso de AINEs y asociar un inhibidor de la bomba de protones en dosis única diaria.
19. Un paciente con dolor abdominal epigástrico muy intenso, asociado a signos marcados de irritación peritoneal, se realiza una radiografía de abdomen de pie, que muestra presencia de neumoperitoneo. La conducta más adecuada es:	a.Administrar cristaloides, antibióticos e inhibidores de la bomba de protones, por vía endovenosa y observar evolución b.Realizar erradicación de Helicobacter pylori c.Solicitar endoscopía digestiva alta d.Resolver quirúrgicamente de inmediato e.Solicitar TAC de abdomen y pelvis
20. El factor pronóstico más importante en el cáncer gástrico es:	a.El tipo histológico del tumor b.El tamaño del tumor c.La presencia de adenopatías metastásicas d.El grado de invasión transmural del tumor e.La edad del paciente

Lia...

CUESTIONARIO 3 GASTROENTEROLOGIA	2024
1. Un paciente de 68 años presenta un cuadro de dolor abdominal tipo urente, de algunos meses de evolución, asociado a sensación de plenitud precoz y vómitos frecuentes después de comer. El diagnóstico de sospecha es:	a.Acalasia esofágica b.Divertículo de Zenker c.Cáncer de esófago d.Cáncer gástrico e.Angina mesentérica
2. Un paciente de 56 años, portador de una cirrosis por consumo crónico de alcohol, consulta por aumento del perímetro abdominal. Actualmente ya no consume alcohol y presenta ascitis moderada en el examen físico, la que se confirma con una ecografía. Se realiza paracentesis diagnóstica, que muestra salida de líquido ascítico transparente con 10 células por mm3 y albúmina de 2,2 g/dl. La conducta más adecuada es:	a.Realizar paracentesis evacuadora, con reposición de albúmina b.Iniciar antibióticos por vía endovenosa c.Iniciar antibióticos orales, de manera profiláctica d.Iniciar espironolactona y furosemida e.Instalar un TIPS
3. Un paciente de 61 años, cirrótico, presenta varios episodios de hematemesis, asociado a ortostatismo. Además de realizar reposición de volumen, se debe:	a.Administrar beta-agonistas adrenérgicos b.Administrar beta-bloqueadores adrenérgicos c.Administrar omeprazol endovenoso d.Instalar un TIPS de manera urgente e.Realizar una endoscopía de urgencia
4. Identifique la asociación correcta entre la patología y su tratamiento de elección:	a.Amebiasis – albendazol b.Giardiasis – praziquantel c.Shiguellosis – amoxicilina d.Diarrea por Clostridium difficile – metronidazol e.Cólera – Cotrimoxazol
5. Una paciente de 28 años presenta un cuadro de diarrea acuosa, de 5 días de evolución, asociado a dolor abdominal tipo cólico. Refiere que presentó sensación febril durante el primer día y también vómitos alimentarios en un par de ocasiones. El diagnóstico más probable es:	a.Colitis parasitaria b.Colitis viral c.Colitis bacteriana d.Colitis ulcerosa e.Colitis pseudomembranosa
6. Un paciente de 30 años presenta pirosis con frecuencia, en especial después de algunas comidas. Además, refiere regurgitación ácida de alimentos. Se solicita una endoscopía digestiva alta, que resulta normal. La conducta más adecuada es:	a.Indicar medidas generales antirreflujo y esomeprazol oral b.Solicitar manometría esofágica c.Iniciar tratamiento erradicador de Helicobacter pylori d.Solicitar radiografías baritadas e.Diagnosticar una dispepsia funcional y realizar educación del paciente
7. Un paciente de 35 años, alcohólico, presenta un cuadro de malestar general, ictericia, fiebre y vómitos. Se solicitan exámenes que muestran: lipasa: 100 UI/L, GGT: 345 UI/L, GOT: 350 UI/L, GPT: 106 UI/L, bilirrubina: 3,8 mg/dl, fosfatasas alcalinas: 108 UI/L. El diagnóstico más probable es:	a.Pancreatitis aguda b.Pancreatitis crónica c.Colédocolitiasis d.Hepatitis alcohólica e.Hepatitis viral
8. Un paciente presenta un síndrome ulceroso, que ha manejado con omeprazol automedicado. Se solicita una endoscopía digestiva alta, que muestra una úlcera duodenal activa, sin signos de sangrado. El test de ureasa es negativo y niega consumir AINES. Respecto a este paciente, es correcto afirmar que:	a.El resultado del test de ureasa probablemente sea un falso negativo, dado el consumo de omeprazol b.Se debe indicar omeprazol a permanencia c.El diagnóstico más probable es cáncer de duodeno d.La enfermedad celíaca es el diagnóstico más probable e.La enfermedad de Cröhn es el diagnóstico más probable
9. Un paciente, con antecedente de promiscuidad sexual, presenta un cuadro de malestar general, gran decaimiento y posteriormente, aparición de ictericia de escleras, mucosas y piel, asociada a coluria y acolia. Se solicitan exámenes, que muestran positividad del antígeno de superficie para VHB y de los anticuerpos IgM anti-core. ¿Qué examen es más adecuado para determinar la gravedad de este paciente?	a.Biopsia hepática b.Niveles plasmáticos de Antígeno de superficie c.Tiempo de protrombina d.Niveles plasmáticos de GOT e.Niveles plasmáticos de bilirrubina
10. Una paciente de 80 años presenta ictericia y coluria de una semana de evolución, sin otros síntomas. El diagnóstico más probable es:	a.Cáncer b.Coledocolitiasis c.Hepatitis d.Síndrome de Gilbert e.Hemólisis
11. ¿Cuál de los siguientes alimentos puede ser ingerido libremente por los pacientes con enfermedad celíaca?:	a.Carne de cerdo b.Galletas c.Tallarines d.Pan

Lia...

	e.Avena
12. Paciente de sexo femenino, de 65 años, inicia dolor en Hipocondrio derecho, muy intenso, asociado a sensación febril. Al día siguiente, el dolor se hace mucho más intenso, agregándose ictericia, fiebre hasta 41°C y desorientación. La analítica sanguínea muestra Hcto: 42%, G. Blancos: 18.200, GOT: 105, GPT: 98, Bili: 6,7, amilasa normal. La ecografía abdominal muestra vesícula biliar normal colédoco de 12 mm de diámetro. El diagnóstico más probable es:	a.Colecistitis aguda b.Pancreatitis aguda c.Hepatitis aguda d.Coledocolitiasis e.Colangitis aguda
13. La positividad de los anticuerpos anti-músculo liso es característica de:	a.Hepatitis autoinmune b.Colangitis esclerosante primaria c.Cirrosis biliar primaria d.Atresia biliar e.Amiloidosis
14. El hígado graso se diagnostica preferentemente mediante:	a.La clínica b.El perfil lipídico c.La ecografía abdominal d.Las pruebas hepáticas e.La biopsia hepática
15. Un paciente consulta por ictericia, constándose elevación marcada de las transaminasas. Se solicitan pruebas de serología viral que demuestran VHA-Ac IgM(-), VHA-Ac IgG (+), VHBs-Ag(+), VHBs-Ac(-), VHBcore-Ac IgM(+), VHBcore-Ac IgG(-), VHC-Ac totales(+). El diagnóstico más probable es:	a.Hepatitis B b.Hepatitis C c.Hepatitis A y B d.Hepatitis B y C e.Hepatitis A, B y C
16. ¿Qué hallazgo o antecedente es MENOS orientador a un trastorno digestivo funcional?	a.Pujo y tenesmo b.Distensión abdominal c.Dolor abdominal tipo cólico d.Constipación e.Diarrea
17. Un paciente de 66 años presenta un cuadro de constipación marcada de 3 días de evolución, sin poder presentar deposiciones, asociado a dolor abdominal. Luego presenta deposiciones diarreicas explosivas en una oportunidad. Refiere además historia de palidez y molestias abdominales de 1 mes de evolución. El examen físico muestra un paciente pálido, con abdomen blando, depresible y el tacto rectal demuestra una ampolla rectal sin deposiciones, sin hallar otras alteraciones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?	a.Vólvulo de colon sigmoides b.Cáncer de colon c.Obstrucción intestinal por bridas d.Síndrome de Ogilvie e.Diverticulitis
18. El hepatocarcinoma se asocia a cirrosis hepática de distintas etiologías. ¿Qué marcador serológico se suele elevar en los pacientes con este tipo de tumor?	a.Ca 19.9 b.Ca 125 c.Antígeno carcinoembrionario d.Alfafetoproteína e.Ferritina decarboxilada
19. La resección del íleon distal produce malabsorción de:	a.Vitamina B12 y ácidos biliares b.Hierro y calcio c.Grasas y polipéptidos d.Vitaminas hidrosolublres e.Polisacáridos
20. Cuatro horas después de acudir a un banquete, 25 personas inician súbitamente un cuadro de náuseas, vómitos y dolores abdominales. ¿Cuál de los siguientes agentes es el causante más probable de estos síntomas?	a.Clostridium botulinum b.Salmonella c.Escherichia coli enterotoxigénica d.Estafilococo áureo e.Shigella